

RAFAEL AUGUSTO FERRAZ			
MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS	Respirador: oral		
BANHEIRO	5x		
HORA QUE ACORDA	6:40		
HORA QUE DORME	22:00		
PRATICA EXERCICIO	Drº Ivan IAH 103.8/b		
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
21/06	P: 14.7 cmH ₂ O		
22/06	IAH = 1.0/lv		
	M. de uso: Ph49'		
Relata que quando está estressado tem dor de cabeça.			
Melhora da disposição ao acordar.			
23/06	P = 13 cmH ₂ O		
22	IAH = 0.5 l/min		
	M. de uso: 6h25		
fuga m. 1 l/min			
fua			
14/07	P = 12.8 cmH ₂ O		
22	IAH = 0.5 l/min		
	M. de uso: 7h		
Bem adaptado, melhora do cansaço.			
29/07	P = 12.8 cmH ₂ O		
22	IAH = 1.0 lv		
	M. de uso: Ph		
esta mais desinchado			
29/08	P = 12.8 cmH ₂ O		
22	IAH = 1.0		
	M. de uso: Ph		
Fuga = 2.2			
29/09	P = 13 cmH ₂ O		
22	IAH = 0.6		
	Fuga = 14.8		
29/11	P = 13 cmH ₂ O		
22	IAH = 0.6 e/lv		
	M. de uso: 6h27'		
	Fuga = 7.2 e/lv		
Bem adaptado, relata melhora do cansaço.			
30/01	P = 13 cmH ₂ O		
23	IAH = 1.0		
	M. de uso: 6h38'		
Bem adaptado, relata que caminha 1Km e fica cf falta de ar. fua			



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
POLISSONOGRAFIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Rafael Augusto Ferraz

EXAME nº: 5035

SOLICITADO POR: Dr. Ivan Senis Cardoso Macedo

DATA: 20/12/2021

IDADE: 41 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h09min e concluído às 06h31min. A latência para o sono foi de 4 minutos e a latência para o estágio REM, de 124 minutos. O tempo total de sono foi de 427 minutos (07h07min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 86,7%. A distribuição do sono mostrou 16,3% de estágio 1, 44,7% de estágio 2, 21,2% de estágio 3 e 17,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 61,5 minutos em vigília, ocorreram 212 microdespertares (índice: 29,8/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 103,3/hora, sendo 33,4 apneia/hora e 69,8 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 103,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 90%, sendo a saturação média de 89% e a mínima de 65%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (103,3/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (103,3/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 63; máxima: 85 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 4 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (124 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (86,7%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 29,8/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (16,3%; normal: 8-10%) e 3 (21,2%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (17,8%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (44,7%; normal: 45-55%) permaneceu no limite inferior da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 9 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP: 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

NS 22211930381

RAFAEL AUGUSTO FERRAZ

SINTOMAS / QUEIXAS
MEDICAMENTOS

HORA QUE ACORDA:

HORA QUE DORME:

BANHEIRO

TIPO DE RESPIRAÇÃO

PRÁTICA EXERCÍCIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

IDADE:

PESO:

IAH:

MALLAMPATI:

SPO2:

22/03 P= 13 cmH₂O
IAH = 0,6
m. de uso: 7hr.
fuga = 5,2

- iniciou natação
- nada disponível - OK

29/05 P= 13 cmH₂O
IAH = 1,1 l/h
m. de uso = 7h56'
fuga = 1,5 l/min

* mais barulhento - ao teste normal
gancho

- mantendo natação.
* horário fixo

31/07/23 P= 13 cmH₂O
IAH = 0,6 l/h
m de uso = 7h30 min
fuga = 1,2 l/min

- mantendo natação / hidroginástica
- bariátrica - vai passar melhor.

25/10 P= 13 cmH₂O
IAH = 0,5 l/h
m. de uso: 7hr
fuga = 0,5

fuga.

11/12/23: P= 13 cmH₂O
IAH = 0,5 l/h
m de uso: 7h20 min
fuga 1,5 l/min.

Bem adaptado

parou atividade física -> perdeu
unidade por aguentar

19/02/24 P= 13 cmH₂O
IAH = 0,5
m de uso: 8h7m

Bem adaptado

pretende voltar a atividade
física

Natasha

13/05/24 P= 13 cmH₂O
IAH = 0,5 l/h
m de uso: 8h2m

Bem adaptado
se temer p/ retornar
atividade física

Natasha

P= 13 cm/h²
IAH= 0,4
fuga: 0.0
m. de uso 8hs

Due

segue caminhada exercício

11/11
2024

P= 13 cm/h²
IAH= 0,5 elh
m. uso: 8h00' min
fuga= 0

Silvia

03/02
2025

P= 13 cm/h²
IAH= 0,5 elh
m. uso: 8h04 min
fuga= 0 el/min

Bem adaptado.
- não faz atividade

Silvia

12/05/25

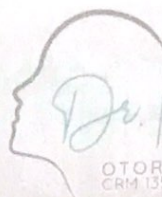
P= 13 cm/h²
IAH= 0,7 elh
m. uso= 8h36 min
fuga= 0 el/min

Bem adaptado

Silvia



(12) 9 8898 - 4278



Dr. Ivan Macedo

OTORRINOLARINGOLOGIA
CRM 135338

Rafael Augusto Ferraz

Solicito adaptação de CPAP.

G47

Dr. Ivan Santos Cardoso Macedo
Otorrinolaringologista
CRM 135338

DR. IVAN MACEDO
OTORRINOLARINGOLOGIA | CRM 135338
Av. Dr. João Guilhermino, 429 - sala 38 - 3º andar
Edifício Saint James - São José dos Campos

Acorda 6h30' Dorme: 22:00 (final 8h)
Empresa (radio / TV) (7 às 19h)
Café: 8h | Almoço: 12:00 | Jantar: 19:30h.
Exercício físico: não faz.

IAH = 103,3 / L Sp médio: 90% Sp = min = 85%
causado / dor de cabeça / perna inchada
HAS / Colesterol / Pré-diabetes
Respiração oral.

Peso 144 Kg. [Endocrinologia - Larissa
Nutri - Ederson